1. Qué se defiende

- Administración registra al médico y le asocia especialidades.
- Recepción y médicos consultan franjas libres de 30 minutos: el horario menos las citas activas.

Evidencia: pruebas APP-01 y APP-02 en micro-his-medicos/tests/ejecutar.php

2. Actores y casos de uso (semana 1)

- Administración escribe; recepción y médico consultan; Citas (M05) aporta las citas ocupadas.
- Siete casos de uso en el UML de la semana 1.

Evidencia: semana-01/semana-01-uml-medicos-disponibilidad.md

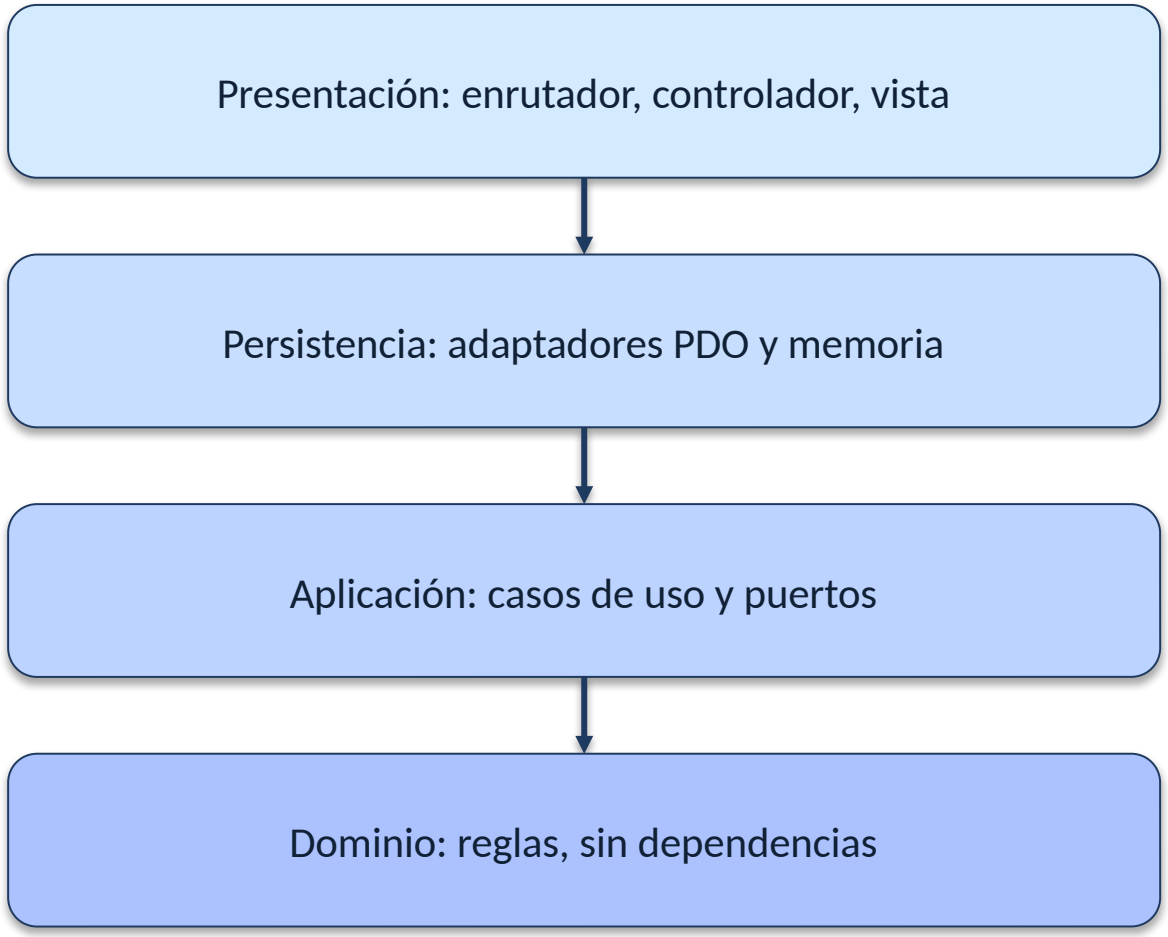
3. Requisitos y SOLID (semana 2)

- RF y RNF con criterios de aceptación.
- El principio defendido es ISP: cada cliente depende de una interfaz pequeña, y el ejemplo antes/después lo comprueba.

Evidencia: semana-02/ejemplo-isp/verificar.php

4. Capas (semana 3)

- Dominio, Aplicación, Persistencia y Presentación.
- Las dependencias van hacia adentro: el Dominio no conoce a nadie y la prueba ARQ-01 lo vigila.

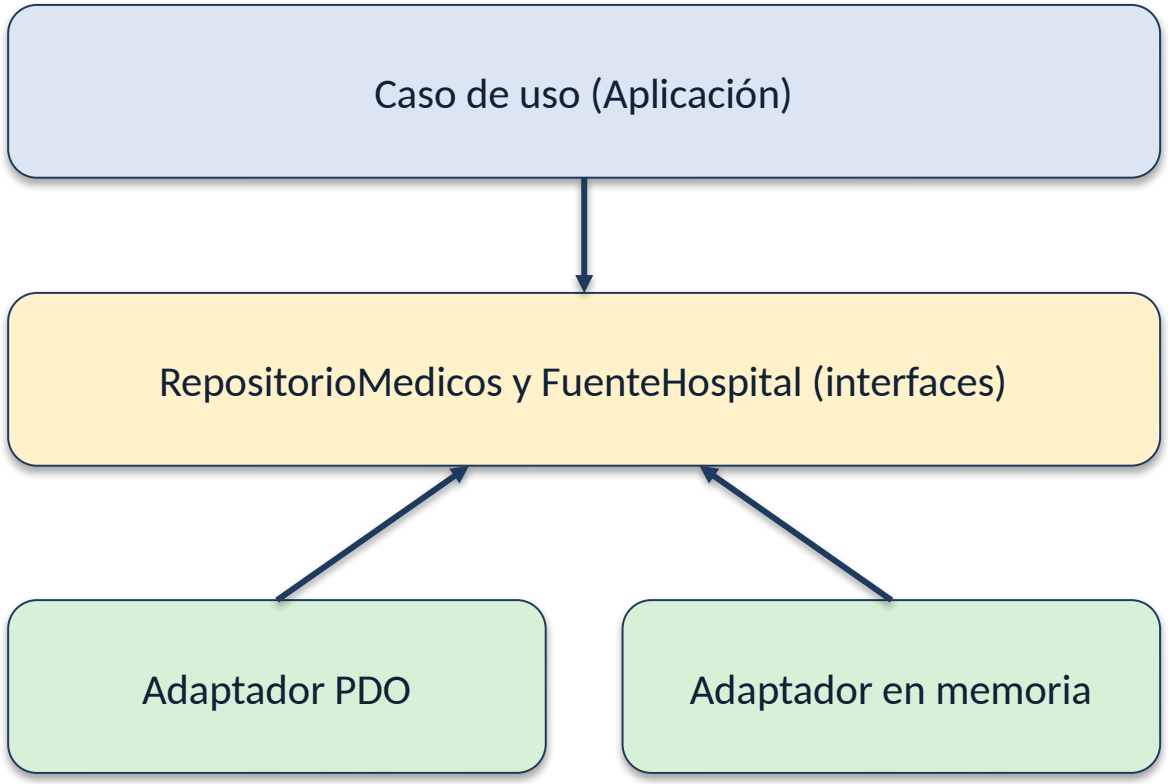


Evidencia: prueba ARQ-01 en micro-his-medicos/tests/ejecutar.php

Las flechas van hacia adentro; el Dominio no conoce a nadie.

5. MVC y Repository (semana 4)

- El caso de uso depende de RepositorioMedicos, lo que escribe, y de FuenteHospital, lo que lee de otros módulos.
- PDO y memoria responden igual (REP-01).



Un adaptador nuevo se conecta sin cambiar el caso de uso (cambio práctico).

Evidencia: micro-his-medicos/src/Aplicacion/Puertos.php

6. API y microservicio (semana 5)

- Contrato con registro, especialidades, disponibilidad y ausencias.
- Decisión: seguir dentro del monolito modular; se dividiría si p95 supera 2 s, hay más de 20 consultas por segundo, otro equipo a cargo o M05 exige otra disponibilidad.

Evidencia: semana-05/semana-05-cliente-servidor-microservicios.md

7. Cambio práctico y límites

- Leer las citas desde la API de Citas en vez de la base se resuelve con una fuente nueva.
- Límites: desactivar médico, horario y ausencias (RF-02, RF-04 y RF-05) están en el contrato y el prototipo, pero no en el Micro-HIS PHP.

Evidencia: semana-06/demostrar-cambio.php